

INDICADO POR:			
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA			
NS			
REGINA SILVA DE SOUZA Mãe			
IDADE: 79	PESO: 63	ALTURA:	PROFISSÃO:
SINTOMAS: sonolência / Tontura / Boca seca / Dor de cabeça / tussão / muito dia			
QUEIXAS: Acorda muitas vezes à noite			
MEDICAMENTOS: Benicar / Kepira / Medoxemile / Clorazepam / Zupays / Glifage / Gabapentina / glicosaminas / Dacorexina			
MÉDICO: Pantoprazol / oclodero / clidronato de sódio			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: 2x caminhada 5'			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5(7:15) ALMOÇO: 5(12) LANCHE: 5(16) JANTAR: 5(19)			
HORA QUE DORME: 22		HORA QUE ACORDA: 3	
COCHILHO ☒ S () N	DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: () S ☒ N	DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N		PET NO QUARTO: () S () N
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 19	SPO2: 54%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Fibrose Pulmonar / CA de mama / Radioterapia / quimioterapia / Isclerose			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA glaucoma			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Insuf. cardíaca			
(S) ORTOPÉDICA	(S) NEUROLÓGICA	() OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N		SPO2 C/ CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
16/04/26 Relata gosto de celular à noite e prox. as 22hr, mas usa o cel. até 18hr.			
Fisiot. resp. 1x semana.			
Fisiot. motora 1x semana.			
Laminado			
ma celular			



PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR

NOME : Souza, Regina Silva de

Data: 27/03/26 15:00:14

DR (A) :

ID: 2659

Idade: 79

Altura (cm) : 150,0

Peso (Kg): 63,0

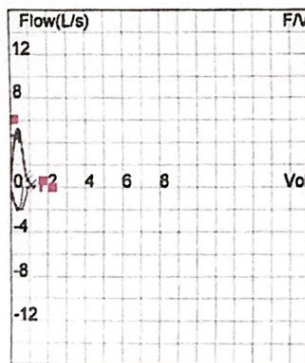
Tabagismo (anos - maço) :

Comentários:

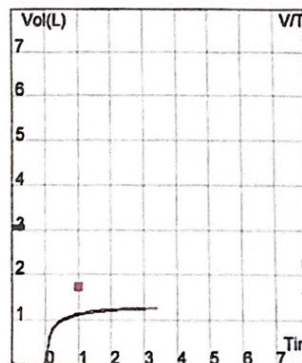
Valores espirométricos abaixo do limite inferior de normalidade, redução proporcional do VEF1 e CVF. Exame compatível com distúrbio ventilatório restritivo moderado. Não houve resposta significativa após a administração do broncodilatador.

Parâmetros	Previstos	Limite inferior	Pre	%Prev	Pós-Bd	%Prev	% Pós/Pre
CVF (L)	2,27	1,63	1,27	56%	1,26	55%	-1%
VEF1 (L)	1,75	1,14	1,15	66%	1,12	64%	-3%
VEF1/CVF	0,78	0,70	0,91	116%	0,89	114%	-2%
FEF25-75% (L/s)	1,78	1,02	1,91	107%	1,83	103%	-4%
FEF25-75/FVC	0,75	0,43	1,51	201%	1,45	194%	-4%
CV (L)	2,27	1,63	—	—	—	—	—
CI (L)	—	—	—	—	—	—	—
VEF1/CV	—	—	—	—	—	—	—

CVF, Fluxo-Volume, Pre e Pos-Bd



CVF, Volume-Tempo, Pre e Pos-Bd



Critérios de melhora VEF1: aumento de 7% do previsto e 200 ml.
CVF: aumento de 350 ml do basal.
CI e/ou CV: aumento de 15% do basal.

Dra Ana Paula Oliveira
CRM 174756 RQE 91801



À Dr Ana Claudia (Fisioterapia especializada em sono)

Paciente REGINA SILVA DE SOUZA portadora de apneia do sono moderada e comprometimento cognitivo

Solicito avaliação para CPAP

Att

24/03/2026

Dr Ana Claudia : 12 - 99724-7053

Dr. Alexandre C. Marques
Neurologista
CRM-SP 146.146

Neurologista

DR. ALEXANDRE COELHO MARQUES

CRM: 146.146

Especialista em Neuroimunologia pelo HCFMUSP



(12) 3921-7333

(12) 99657-4866

RUA EUCLÍDES MIRAGAIA,
145 - 613. CENTRO, SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS - SÃO PAULO

Exame

Nome Regina Silva Souza
Início 06/01/2026 - 21:50:23
Fim 07/01/2026 - 06:08:31

Nascimento 05/01/1947 (79 anos) Sexo Feminino
Tempo total 08:18:08 (498,1 min)
Tempo válido 07:53:03 (473,1 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☐ Placa de bruxismo
☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço mandibular
☐ Terapia posicional
☐ Oxigênio
☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 06/01/2026

Peso 60 kg
Altura 1,50 m
IMC 26,7

Medicamentos

Respondido em 06/01/2026

- ☐ Nenhum
☒ alendronato de sódio 70 n
☒ benicar odt 20 1-0-0
☒ clobazam 10 0-0-1
☒ diacarina 50 mg 0-1-0
☒ furosemda 40 mg 1-0-0
☒ gabapentina 300 mg 1-0-0
☒ glicosamina 500 mg cond

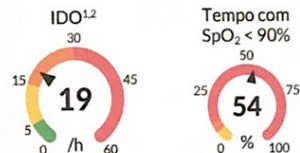
Sintomas Respondido em 06/01/2026

- ☐ Nenhum
☒ Ronco alto e frequente
☐ Sonolência excessiva diurna
☒ Sono não reparador
☒ Despertares frequentes
☐ Engasgos noturnos
☐ Refluxo gastroesofágico
☒ Cefaleia matinal
☒ Dificuldade de concentração
☒ Perda de memória
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 06/01/2026

- ☐ Nenhuma
☒ Hipertensão arterial
☒ Diabetes
☐ Dislipidemia
☒ Câncer
☐ Depressão
☐ Arritmia cardíaca
☐ Infarto agudo do miocárdio
☐ Angina
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Bronquite / Enfisema
☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 06/01/2026, iniciado às 21:50 e terminado às 06:08. O tempo total de registro foi de 8h18min (498 minutos) e o tempo válido foi de 7h53min (473 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 148 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 18,8/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 90% e permaneceu abaixo de 90% durante 54% do tempo de registro (258 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 55% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 18,8/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

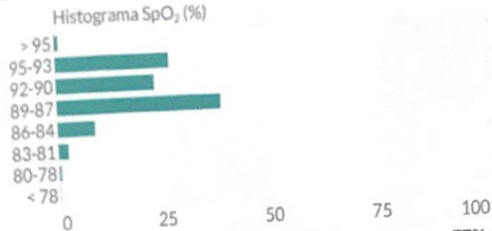
1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

Exame

Nome Regina Silva Souza
Início 06/01/2026 - 21:50:23

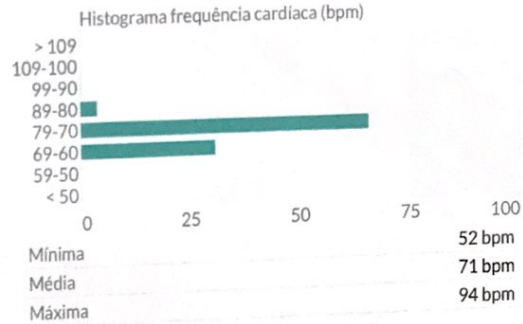
Nascimento 05/01/1947 (79 anos) Sexo Feminino
Tempo total 08:18:08 (498,1 min)

Oximetria (SpO₂)



SpO₂ mínima 77%
SpO₂ média 90%
SpO₂ máxima 97%
Tempo com SpO₂ < 90% 258,9 min (54%)
Número de dessaturações¹ 148
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2} 18,8 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs) 17,4 /hora
Número de eventos de hipoxemia³ 1
Tempo total em hipoxemia³ 10,8 min (2%)

Frequência cardíaca

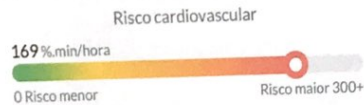


Sono estimado

Tempo total de sono 440,5 min
Tempo para dormir 20,5 min
Tempo acordado pós-sono 31,0 min
Eficiência do sono 88%

Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 168,5 %min /hora

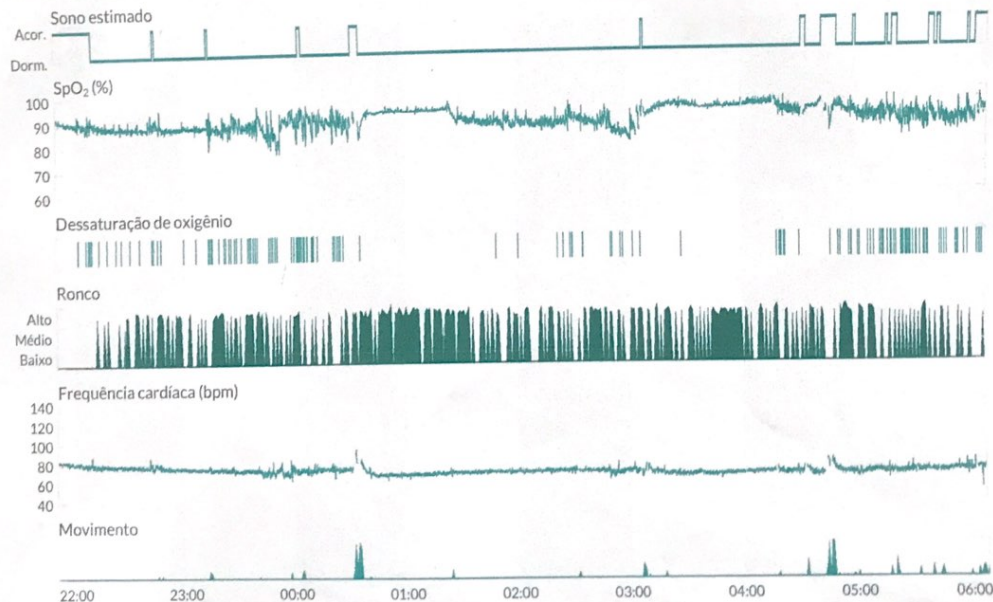


Análise de ronco

Tempo de gravação 499,0 min
Tempo com ronco 274,5 min (55%)



Polissonogramas



Nº de série Oxistar 08514, versão do firmware 02.001.001
Aplicativo: plataforma android, versão 2/1.17.4
Processamento: examprocserver-1.12.0, examreport-?
Documento gerado em 07/01/2026 às 23:45:55 BRT